



Recommandations de l'OMS concernant les soins maternels et néonataux pour une expérience positive de la période postnatale

Résumé analytique

Introduction

La période postnatale, définie ici comme la période commençant immédiatement après la naissance du bébé et s'étendant jusqu'à six semaines (42 jours), est une période critique pour les femmes, les nouveau-nés, les partenaires, les parents, les aidants et les familles. Pourtant, le fardeau de la mortalité et de la morbidité maternelles et néonatales au cours de cette période reste inacceptablement élevé, et les possibilités d'améliorer le bien-être des femmes et d'offrir des soins attentifs aux nouveau-nés n'ont pas été pleinement exploitées. Les services de soins postnatals sont une composante fondamentale du continuum de soins à la femme, au nouveau-né et à l'enfant, et sont essentiels à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) en matière de santé reproductive, maternelle et infantile, notamment les objectifs visant à réduire les taux de mortalité maternelle et à mettre fin aux décès évitables de nouveau-nés.

En accord avec les ODD et la *stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents*, et conformément à une approche fondée sur les droits de l'homme, les efforts en matière de soins postnatals doivent aller au-delà de la seule couverture et de la survie pour inclure la qualité et l'expérience des soins. Cette directive vise à améliorer la qualité des soins postnatals essentiels et de routine pour les femmes et les nouveau-nés, dans le but d'améliorer la santé et le bien-être maternel et néonatale. Elle reconnaît qu'une « expérience postnatale positive » constitue un critère important pour toutes les femmes qui accouchent, les nouveau-nés, les parents et les aidants, et jette les bases d'une amélioration de la santé et du bien-être

à court et à long terme. Une expérience positive de la période postnatale est définie comme une expérience dans laquelle les femmes, les partenaires, les parents, les aidants et les familles reçoivent des informations, sont rassurés et bénéficient d'un soutien de manière cohérente de la part de prestataires de soins motivés; et où un système de soins de santé flexible et doté de ressources reconnaît les besoins des femmes et des nouveau-nés, et respecte leur contexte culturel.

La présente directive réunit des recommandations nouvelles et existantes sur les soins postnatals de routine pour les femmes et les nouveau-nés aussi bien en établissement de soins, qu'en communauté, et quel que soit le contexte en termes de ressources. Elle fournit un ensemble complet de recommandations pour les soins pendant la période postnatale, en se concentrant sur le paquet essentiel que toutes les femmes et tous les nouveau-nés devraient recevoir, en accordant une attention particulière à la qualité de soins, c'est-à-dire à la fois l'offre et à l'expérience de soins. Cette directive met à jour et va au-delà des directives *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn* de 2014 sur les soins postnatals de la mère et du nouveau-né. Elle complète par ailleurs, les directives existantes de l'OMS sur la prise en charge des complications postnatals.

Public cible

Les recommandations de cette directive ont pour but d'informer le développement de politiques de santé, de protocoles cliniques et de guides programmatiques nationaux et sous-nationaux pertinents. Par conséquent, le public cible comprend les décideurs nationaux

et infranationaux en matière de santé publique, les responsables de la mise en œuvre et de la gestion des programmes de santé maternelle, néonatale et infantile, les responsables d'établissements de santé, le personnel de santé (y compris les sages-femmes, les infirmiers auxiliaires, les infirmiers, les obstétriciens, les pédiatres, les néonatalogistes, les médecins généralistes et le personnel de santé communautaire), les organisations non gouvernementales, les associations professionnelles impliquées dans la planification et la gestion des services de santé maternelle, néonatale et infantile, le personnel universitaire impliqué dans la formation du personnel de santé et les groupes de femmes et de parents.

Les termes femme, mère, partenaire, parents et aidants ont été utilisés tout au long de cette directive. Ces termes ont été définis dans le but de promouvoir l'inclusion de toutes les personnes qui ont donné naissance, et en reconnaissance des rôles divers de toutes les personnes impliquées dans l'offre de soins et de soutien pendant la période postnatale.

Méthodes d'élaboration des directives

La directive a été élaborée à l'aide de procédures opérationnelles standard, conformément au processus décrit dans le *manuel de l'OMS pour l'élaboration de directives*. En bref, ces procédures comprennent: (i) l'identification des questions et des résultats prioritaires; (ii) la recherche et la synthèse des preuves; (iii) l'évaluation des preuves; (iv) la formulation de recommandations; et (v) la planification de la mise en œuvre, de la diffusion, de l'évaluation de l'impact et de la mise à jour de la directive. La qualité des preuves scientifiques étayant les recommandations a été évaluée en utilisant les approches GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) et CERQual (Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research) pour les preuves quantitatives et qualitatives, respectivement. Les résultats des études individuelles sur le rapport coût-efficacité ont été évalués à l'aide de la liste de contrôle du Consensus Health Economic Criteria (CHEC). Le cadre DECIDE (Developing and Evaluating Communication Strategies to support Informed Decisions and Practice based on Evidence), un outil permettant de passer des preuves à la décision, a été utilisé pour guider la compilation des preuves, les jugements sur les différents critères et la formulation des recommandations par le groupe de rédaction des lignes directrices (GDG), notamment: les effets d'une intervention sur les résultats maternels, néonatales et les systèmes de santé, et les considérations relatives aux valeurs des femmes, des parents et des travailleurs de la santé, les ressources, l'équité, l'acceptabilité et la faisabilité des interventions. Le GDG est un groupe international d'experts réunis dans le but d'élaborer cette ligne directrice – lors de neuf réunions virtuelles du GDG tenues entre septembre 2020 et juin 2021. En outre, les recommandations existantes issues des

directives actuelles de l'OMS approuvées par le Comité d'examen des directives, qui étaient pertinentes pour les soins postnatals, ont été identifiées et intégrées dans ces directives afin de fournir un document complet aux utilisateurs finaux.

Recommandations

Les réunions du GDG ont abouti à 63 recommandations relatives aux soins postnatals: 31 sont des recommandations nouvellement élaborées par le GDG et 32 sont des recommandations intégrées à partir de directives existantes de l'OMS. Ces recommandations sont regroupées en fonction des soins maternels, des soins aux nouveau-nés, des systèmes de santé et des interventions de promotion de la santé (pour améliorer l'offre, l'utilisation et l'expérience des soins postnatals). Les interventions ont été classées comme recommandées, non recommandées ou recommandées sous certaines conditions en fonction des délibérations du GDG selon les critères DECIDE qui ont informé l'orientation et la catégorie de la recommandation. Lorsque le GDG a recommandé ou n'a pas recommandé une intervention, la recommandation qui en résulte est pertinente pour toutes les femmes en période post-partum et les nouveau-nés. Lorsque le GDG a recommandé une intervention uniquement dans des contextes spécifiques, il a jugé que les preuves ne s'appliquaient qu'à ces situations, contextes ou populations. Pour toutes les recommandations, les experts contributeurs ont fourni des remarques, y compris des informations contextuelles supplémentaires relatives aux recommandations spécifiques au contexte, si nécessaire. Les utilisateurs de la directive devraient se référer à ces remarques, qui sont présentées avec les résumés des preuves dans la version complète de la directive.

Mise en œuvre

Ces recommandations doivent être mises en œuvre dans le cadre d'un modèle approprié de soins postnatals et adaptées aux besoins des différents pays, des contextes locaux et des femmes, nouveau-nés, parents, aidants et familles. Le GDG a proposé des considérations de mise en œuvre pour chacune des recommandations nouvelles et/ou actualisées, ainsi que des considérations générales pour l'adoption, l'adaptation et la mise en œuvre de l'ensemble des recommandations afin de garantir des soins respectueux, individualisés et centrés sur la personne à chaque contact, conformément à une approche fondée sur les droits de l'homme.

Le modèle de soins postnatals de l'OMS place la dyade femme-nouveau-né au centre des soins (Fig. 1). La base de ce modèle de soins postnatals est un minimum de quatre contacts de soins postnatals. En particulier, le GDG a considéré que les deux premières semaines après la naissance étaient une période clé pour promouvoir la santé, identifier les problèmes de santé et soutenir la

transition vers les soins aux femmes et aux nourrissons. La présente directive confirme l'importance des soins postnatals pendant les 24 premières heures suivant la naissance, quel que soit le lieu de naissance. Plus précisément, elle recommande un séjour minimum de 24 heures après la naissance dans l'établissement de santé, avec des soins et une surveillance continus pendant ce séjour. Des critères élargis avant la sortie ont été définis pour évaluer et gérer les problèmes potentiels et préparer le retour à la maison. Au moins trois autres contacts de soins postnatals ont lieu au cours des six premières semaines après la naissance. Il s'agit notamment de fournir des pratiques cliniques efficaces, des informations pertinentes et opportunes, ainsi qu'un soutien psychosocial et émotionnel, assurés par des agents de santé bienveillants, compétents et motivés, qui travaillent au sein d'un système de santé qui fonctionne bien. Un système d'orientation efficace, comprenant la communication entre les prestataires de soins de l'établissement et de la communauté, et entre les travailleurs de santé et les transporteurs en cas de complications, sont également des éléments essentiels de ce modèle de soins postnatals.

Suivi et évaluation

La mise en œuvre et l'impact de ces recommandations feront l'objet d'un suivi au niveau des services de santé,

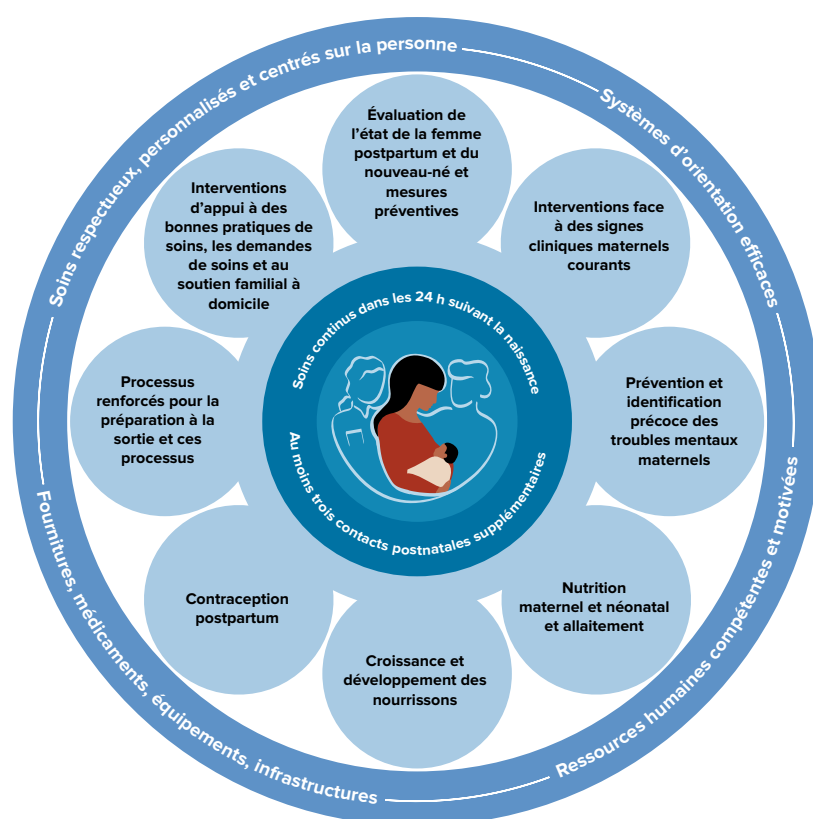
au niveau infranational et au niveau national, sur la base de critères et d'indicateurs clairement définis, associés à des objectifs convenus localement. Le GDG suggère de prendre en compte les indicateurs suivants, qui ont été adaptés des indicateurs mondiaux actuellement recommandés.¹

- Durée du séjour dans les établissements de santé après la naissance
- Soins postnatals de routine précoces pour les femmes (dans les deux jours)
- Soins postnatals de routine précoces pour les nouveau-nés (dans les deux jours)
- Vaccination contre l'hépatite B à la naissance

Mise à jour des recommandations

Conformément au processus de mise à jour des directives de l'OMS, un processus systématique et continu visant à identifier et à combler les lacunes des données probantes après la diffusion des directives sera utilisé. Si de nouvelles preuves susceptibles d'avoir un impact sur la base de preuves actuelle de l'une des recommandations sont identifiées, la recommandation sera mise à jour. L'OMS accueillera volontiers les suggestions concernant des questions supplémentaires à inclure dans les futures mises à jour de la directive.

Figure 1. Représentation schématique du modèle de soins postnatals de l'OMS



¹ Portail de données de l'OMS sur la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent et le vieillissement. Lien internet: www.who.int/data/maternal-newborn-child-adolescent-ageing/maternal-and-newborn-data/maternal-and-newborn---coverage.

Liste récapitulative des recommandations sur les soins maternels et néonataux pour une expérience positive de la période postnatale

Catégorie de soins	Recommandation	Catégorie de recommandation
A. SOINS MATERNELS		
Évaluation de la mère		
Évaluation physiologique de la femme²	1. Toutes les femmes en post-partum doivent faire l'objet d'une évaluation régulière des saignements vaginaux, du tonus utérin, de la hauteur utérine, de la température et de la fréquence cardiaque (pouls), de manière systématique pendant les 24 premières heures, à partir de la première heure après la naissance. La tension artérielle doit être mesurée peu après la naissance. Si elle est normale, la deuxième prise de la tension artérielle doit être effectuée dans les 6 heures. La miction doit être documentée dans les 6 heures. Lors de chaque contact postnatal ultérieur, au-delà de 24 heures après la naissance, il convient de continuer à s'enquérir du bien-être général et d'évaluer les points suivants: miction et incontinence urinaire, fonction intestinale, cicatrisation de toute plaie périnéale, maux de tête, fatigue, douleurs dorsales, douleurs périnéales et hygiène périnéale, douleurs mammaires, sensibilité utérine et lochies.	Recommandé
Dépistage de rattrapage du VIH³	2a. Dans les contextes à forte charge^a de morbidité due au VIH, un dépistage de rattrapage du VIH post-partum est nécessaire pour les femmes séronégatives ou de statut inconnu si le premier dépistage prénatal précoce ou la répétition du dépistage en fin de grossesse au cours de la visite du troisième trimestre ont été omis ou retardés.	Recommandation spécifique au contexte
	2b. Dans les contextes à faible charge^b de morbidité due au VIH,^b il est possible d'envisager un dépistage de rattrapage du VIH post-partum pour les femmes séronégatives ou de statut inconnu si le premier dépistage prénatal précoce ou la répétition du dépistage en fin de grossesse au cours de la visite du troisième trimestre ont été omis ou retardés dans le cadre des efforts visant à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Les pays pourraient envisager cette possibilité uniquement pour les femmes qui sont dans un couple sérodiscordant, lorsque la charge virale du partenaire n'est pas supprimée sous traitement antirétroviral, ou qui présentent d'autres risques connus d'infection au VIH en fin de grossesse au cours de la visite du troisième trimestre.	Recommandation spécifique au contexte
Dépistage de la tuberculose⁴	3a. Un dépistage systématique de la tuberculose peut être effectué dans la population générale, y compris chez les femmes en période post-partum, dans les zones où la prévalence de la tuberculose est estimée à 0,5 % ou plus.	Recommandation spécifique au contexte
	3b. Dans les milieux où la prévalence de la tuberculose dans la population générale est de 100/100 000 habitants ou plus, un dépistage systématique de la tuberculose peut être effectué chez les femmes en période post-partum.	Recommandation spécifique au contexte
	3c. Les contacts familiaux et autres contacts étroits des personnes atteintes de tuberculose, y compris les femmes en période post-partum et les nouveau-nés, doivent faire l'objet d'un dépistage systématique de la tuberculose.	Recommandé

a Les milieux à forte prévalence sont définis dans la publication de l'OMS de 2015 *Consolidated guidelines on HIV testing services* comme des milieux où la prévalence du VIH est supérieure à 5 % dans la population testée.

b Les milieux à faible prévalence sont des milieux où la prévalence du VIH est inférieure à 5 % dans la population testée.

2 Adapté et intégré à partir des *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn* de 2014.

3 Adapté et intégré à partir de la publication de l'OMS *Lignes directrices unifiées sur les services de dépistage du VIH*, 2019.

4 Adapté et intégré à partir de *WHO operational handbook on tuberculosis Module 2: Screening – Systematic screening for tuberculosis disease* de 2021.

Catégorie de soins	Recommandation	Catégorie de recommandation
Interventions concernant les signes cliniques courants		
Refroidissement local pour le soulagement de la douleur périnéale	4. Le refroidissement local, par exemple à l'aide de poches de glace ou de coussins froids, peut être proposé aux femmes dans la période post-partum immédiate pour soulager la douleur aiguë due à un traumatisme périnéal subi pendant l'accouchement, en fonction des préférences de la femme et des options disponibles.	Recommandé
Analgésiques oraux pour soulager les douleurs périnéales	5. Le paracétamol oral est recommandé comme choix de première intention lorsqu'une analgésie orale est nécessaire pour soulager la douleur périnéale post-partum.	Recommandé
Soulagement pharmacologique de la douleur due aux crampes/involutions utérines	6. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) oraux peuvent être utilisés lorsqu'une analgésie est nécessaire pour soulager la douleur post-partum due aux crampes utérines après l'accouchement, en fonction des préférences de la femme, de l'expérience du clinicien en matière d'analgésiques et de la disponibilité.	Recommandé
Entraînement des muscles du plancher pelvien pour le renforcement du plancher pelvien	7. Pour les femmes en post-partum, il n'est pas recommandé de commencer un entraînement systématique des muscles du plancher pelvien après l'accouchement pour prévenir l'incontinence urinaire et fécale du post-partum.	Non recommandé
Interventions non pharmacologiques pour traiter l'engorgement mammaire post-partum	8. Pour le traitement de l'engorgement mammaire dans la période post-partum, les femmes doivent être conseillées et soutenues pour pratiquer un allaitement adapté, une bonne position et une bonne fixation du bébé au sein, l'expression du lait maternel et l'utilisation de compresses chaudes ou froides, selon les préférences de la femme.	Recommandé
Interventions pharmacologiques pour traiter l'engorgement mammaire post-partum	9. L'utilisation d'interventions pharmacologiques telles que l'ocytocine sous-cutanée et l'enzymothérapie protéolytique pour le traitement de l'engorgement mammaire dans la période post-partum n'est pas recommandée.	Non recommandé
Mesures préventives		
Interventions non pharmacologiques pour prévenir les mastites post-partum	10. Pour prévenir les mastites dans la période post-partum, il faut conseiller et soutenir les femmes pour qu'elles pratiquent un allaitement adapté, une bonne position et une bonne fixation du bébé au sein, l'expression manuelle du lait maternel et l'utilisation de compresses chaudes ou froides, selon les préférences de la femme.	Recommandé
Interventions pharmacologiques pour prévenir les mastites post-partum	11. Une antibioprophylaxie orale ou topique de routine pour la prévention de la mastite dans la période post-partum n'est pas recommandée.	Non recommandé
Prévention de la constipation post-partum	12. Des conseils diététiques et des informations sur les facteurs associés à la constipation doivent être proposés aux femmes pour prévenir la constipation post-partum.	Recommandé
	13. L'utilisation systématique de laxatifs pour la prévention de la constipation post-partum n'est pas recommandée.	Non recommandé
Prévention de l'infection péripartum maternelle après un accouchement par voie basse sans complication⁵	14. L'antibioprophylaxie de routine chez les femmes ayant accouché par voie basse sans complication n'est pas recommandée.	Non recommandé

5 Intégrée de WHO recommendations for prevention and treatment of maternal peripartum infections de 2015.

Catégorie de soins	Recommandation	Catégorie de recommandation
Traitement préventif anthelminthique⁶	15. La chimioprévention (déparasitage), reposant sur l'administration annuelle ou semestrielle ^c d'une dose unique d'albendazole (400 mg) ou de mébendazole (500 mg), est recommandée en tant qu'intervention de santé publique auprès des toutes les adolescentes qui ne sont pas enceintes et des femmes en âge de procréer, y compris les femmes en post-partum et les femmes allaitantes, vivant dans des zones où la prévalence de départ d'une quelconque géohelminthiase est égale ou supérieure à 20 % parmi les adolescentes et les femmes en âge de procréer, afin de réduire la charge parasitaire des géohelminthiases.	Recommandation spécifique au contexte
Traitement préventif de la schistosomiase⁷	16a. Dans les communautés endémiques où la prévalence de schistosomiase est de 10 % ou plus, l'OMS recommande une chimiothérapie préventive annuelle au praziquantel en une seule dose pour > 75 % à 100 % des femmes enceintes après le premier trimestre, et des adolescentes non enceintes et des femmes en âge de procréer, y compris les femmes en post-partum et celles allaitantes, afin de contrôler la morbidité liée à la schistosomiase et de progresser vers l'élimination de la maladie en tant que problème de santé publique.	Recommandation spécifique au contexte
	16b. Dans les communautés endémiques où la prévalence de schistosomiase est inférieure à 10 %, l'OMS suggère l'une des deux approches suivantes en fonction des objectifs et des ressources des programmes: (i) lorsqu'il y a eu un programme de chimiothérapie préventive régulière, la poursuite de la chimiothérapie préventive à la même fréquence ou à une fréquence réduite en vue d'interrompre la transmission; (ii) lorsqu'il n'y a pas eu de programme de chimiothérapie préventive régulière, une approche clinique de type « tester et traiter », au lieu d'une chimiothérapie préventive ciblant une population.	Recommandation spécifique au contexte
Prophylaxie orale de pré-exposition pour la prévention du VIH⁸	17. La prophylaxie pré-exposition (PrEP) orale contenant du fumarate de ténofovir disoproxil (TDF) devrait être commencée ou poursuivie comme choix de prévention supplémentaire pour les femmes en post-partum et/ou allaitantes présentant un risque substantiel ^d d'infection par le VIH dans le cadre d'approches de prévention combinée du VIH.	Recommandation spécifique au contexte

Interventions en matière de santé mentale

Dépistage de la dépression et de l'anxiété post-partum	18. Le dépistage de la dépression et de l'anxiété post-partum à l'aide d'un instrument validé est recommandé et doit s'accompagner de services de diagnostic et de prise en charge pour les femmes dont le test est positif.	Recommandé
Prévention de la dépression et de l'anxiété post-partum	19. Des interventions psychosociales et/ou psychologiques pendant la période prénatale et postnatale sont recommandées pour prévenir la dépression et l'anxiété post-partum.	Recommandé

Interventions nutritionnelles et activité physique

Supplémentation orale post-partum en fer et en folates⁹	20. Une supplémentation orale en fer, seule ou associée à une supplémentation en acide folique, peut être fournie aux femmes en post-partum pendant 6 à 12 semaines après l'accouchement pour réduire le risque d'anémie dans les contextes où l'anémie gestationnelle est un problème de santé publique. ^e	Recommandation spécifique au contexte
---	---	---------------------------------------

^c Une administration semestrielle est recommandée lorsque la prévalence de base dépasse 50 %.

^d Le risque substantiel est provisoirement défini comme une incidence du VIH supérieure à trois pour 100 personnes-années en l'absence de PrEP.

^e L'OMS considère qu'une prévalence de 20 % ou plus de l'anémie gestationnelle dans la population est un problème de santé publique modéré.

6 Adapté et intégré à partir de la publication de l'OMS *Lignes directrices : la chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque* de 2018.

7 Adapté et intégré à partir de *WHO guideline on control and elimination of human schistosomiasis* de 2022.

8 Adapté et intégré à partir de la publication de l'OMS *Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: Recommendations for a public health approach – Second edition* de 2016.

9 Intégré à partir de la publication de l'OMS *Iron supplementation in postpartum women* de 2016.

Catégorie de soins	Recommandation	Catégorie de recommandation
Supplémentation en vitamine A pendant la période post-partum¹⁰	21. L'administration d'une supplémentation en vitamine A aux femmes post-partum dans le but de prévenir la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles n'est pas recommandée.	Non recommandé
Activité physique et comportement sédentaire¹¹	22. Les femmes post-partum sans contre-indication devraient : - pratiquer une activité physique régulière tout au long du post-partum; - faire au moins 150 minutes d'activité physique par semaine pour en retirer des bénéfices substantiels sur le plan de la santé; et - incorporer une variété d'activités physiques et de renforcement musculaire; il peut également s'avérer bénéfique de pratiquer des exercices d'étirement musculaire en douceur.	Recommandé
	23. Les femmes post-partum devraient limiter leur temps de sédentarité. Remplacer la sédentarité par une activité physique, de tout niveau d'intensité (y compris faible de intensité), apporte des bénéfices pour la santé.	Recommandé
Contraception		
Contraception post-partum¹²	24. Fournir des informations et des services complets en matière de contraception à l'occasion des soins post-partum est recommandé.	Recommandé

B. SOINS AUX NOUVEAU-NÉS

Évaluation du nouveau-né

Évaluation des signes de danger chez le nouveau-né¹³	25. Les signes suivants doivent être évalués lors de chaque contact postnatal, et le nouveau-né doit être orienté vers une évaluation plus approfondie si l'un de ces signes est présent: mauvaise alimentation, antécédents de convulsions, respiration rapide (fréquence respiratoire > 60 par minute), tirage thoracique sévère, absence de mouvement spontané, fièvre (température > 37,5 °C), température corporelle basse (température < 35,5 °C), jaunisse dans les 24 heures suivant la naissance, ou paumes et plantes de pied jaunes à tout âge. Les parents et la famille doivent être encouragés à consulter rapidement un médecin s'ils constatent l'un des signes de danger ci-dessus entre les visites de soins postnataux.	Recommandé
Dépistage systématique des anomalies oculaires	26. Le dépistage systématique des anomalies oculaires chez le nouveau-né est recommandé et doit s'accompagner de services de diagnostic et de prise en charge des enfants identifiés comme présentant une anomalie.	Recommandé
Dépistage systématique de la déficience auditive	27. Le dépistage systématique de la surdité chez le nouveau-né (UNHS) avec les émissions otoacoustiques (OAE) ou la réponse auditive automatisée du tronc cérébral (AABR) est recommandé pour l'identification précoce de la perte auditive bilatérale permanente (PBHL). L'UNHS doit s'accompagner de services de diagnostic et de gestion pour les enfants identifiés comme souffrant d'une perte auditive.	Recommandé
Dépistage universel de l'hyperbilirubinémie néonatale	28. Le dépistage universel de l'hyperbilirubinémie néonatale par bilirubinomètre transcutané (BTc) est recommandé à la sortie de l'établissement de santé.	Recommandé
	29. Les preuves sont insuffisantes pour recommander ou non un dépistage universel par la bilirubine sérique totale (BST) à la sortie de l'établissement de santé.	Aucune recommandation émise

10 Intégré à partir de la publication de l'OMS *Directive : supplémentation en vitamine A chez les femmes pendant la période postnatale* de 2011.

11 Adaptée et intégrée à partir des *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour* de 2020.

12 Adapté et intégré à partir de la publication de l'OMS *Garantir les droits de l'homme lors de la fourniture d'informations et de services en matière de contraception : orientations et recommandations* de 2014.

13 Adapté et intégré des *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn* de 2014.

Catégorie de soins	Recommandation	Catégorie de recommandation
Mesures préventives		
Moment du premier bain pour prévenir l'hypothermie et ses séquelles	30. Le premier bain d'un nouveau-né à terme et en bonne santé doit être retardé d'au moins 24 heures après la naissance.	Recommandé
Utilisation d'émollients pour la prévention des affections cutanées	31. L'application systématique d'émollients topiques chez les enfants nés à terme et en bonne santé pour la prévention des affections cutanées n'est pas recommandée.	Non recommandé
Application de chlorhexidine sur le moignon du cordon ombilical pour la prévention des infections néonatales	32a. Il est recommandé de garder le cordon ombilical propre et sec.	Recommandé
	32b. L'application quotidienne de chlorhexidine à 4 % (solution aqueuse ou gel de digluconate de chlorhexidine à 7,1 %, délivrant 4 % de chlorhexidine) sur le moignon du cordon ombilical au cours de la première semaine après la naissance n'est recommandée que dans les milieux où des substances traditionnelles nocives (telles que les déjections animales) sont couramment utilisées sur le cordon ombilical.	Recommandation spécifique au contexte
Position de sommeil pour la prévention du syndrome de mort subite du nourrisson	33. Il est recommandé de coucher le bébé sur le dos pendant la première année suivant la naissance afin de prévenir la mort subite du nourrisson (MSN) et la mort subite inattendue du nourrisson (MSI).	Recommandé
Vaccination pour la prévention des infections¹⁴	34. La vaccination des nouveau-nés doit être encouragée conformément aux dernières recommandations de l'OMS en matière de vaccination de routine.	Recommandé
Interventions nutritionnelles		
Supplémentation néonatale en vitamine A	35a. La supplémentation néonatale systématique en vitamine A n'est pas recommandée pour réduire la mortalité néonatale et infantile.	Non recommandé
	35b. Dans les milieux disposant de données récentes (au cours des cinq dernières années) et fiables indiquant un taux de mortalité infantile élevé (supérieur à 50 pour 1 000 naissances vivantes ^f) et une prévalence élevée de carence maternelle en vitamine A (> 10 % des femmes enceintes ayant des concentrations sériques de rétinol < 0,70 µmol/L), l'administration aux nouveau-nés d'une dose orale unique de 50 000 UI de vitamine A dans les 3 premiers jours suivant la naissance peut être envisagée pour réduire la mortalité infantile.	Recommandation spécifique au contexte
Supplémentation en vitamine D pour les enfants nés à terme et allaités au sein	36. La supplémentation en vitamine D chez les nourrissons nés à terme et allaités au sein n'est recommandée pour améliorer la santé des nourrissons que dans le cadre d'une recherche rigoureuse.	Recommandation spécifique au contexte
Croissance et développement du nourrisson		
Massage complet du corps	37. Le massage doux de l'ensemble du corps peut être envisagé pour les enfants nés à terme et en bonne santé, en raison de ses avantages possibles pour la croissance et le développement.	Recommandé
Développement de la petite enfance¹⁵	38. Tous les nourrissons et les enfants doivent recevoir des soins adaptés entre 0 et 3 ans; les parents et les autres personnes qui s'occupent d'eux doivent être soutenus pour fournir des soins adaptés.	Recommandé

f Le taux de mortalité infantile proposé, supérieur à 50 pour 1 000 naissances vivantes, a été calculé sur la base de plusieurs hypothèses: 50 % du taux total de mortalité infantile sont des décès néonataux; 50 % de la mortalité néonatale se produit dans le premier jour après la naissance; le taux de mortalité post-néonatale jusqu'à l'âge de 6 mois représente deux tiers (2/3) du taux total de mortalité infantile, et le taux de mortalité entre 6 et 12 mois représente le tiers restant (1/3); le taux de 30 décès pour 1 000 utilisé dans les études tient compte des décès survenus entre l'inscription dans l'étude et l'âge de 6 mois; et le dosage/l'inscription a presque toujours eu lieu dans les 24 premières heures après la naissance.

14 Adapté et intégré des *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn* de 2014.

15 Adapté et intégré à partir du document *Improving early childhood development: WHO guideline* de 2020.

Catégorie de soins	Recommandation	Catégorie de recommandation
	39. Tous les nourrissons et les enfants devraient bénéficier d'activités d'apprentissage précoce avec leurs parents et les autres personnes qui s'occupent d'eux entre 0 et 3 ans. Les parents et les autres personnes qui s'occupent d'eux devraient être soutenus pour participer à l'apprentissage précoce avec leurs nourrissons et leurs enfants.	Recommandé
	40. Le soutien aux soins adaptés et à l'apprentissage précoce devrait faire partie des interventions visant à assurer une nutrition optimale des nouveau-nés, des nourrissons et des jeunes enfants.	Recommandé
	41. Les interventions psychosociales visant à soutenir la santé mentale de la mère doivent être intégrées aux services de santé et de développement de la petite enfance.	Recommandé

Allaitement maternel

Allaitement exclusif¹⁶	42. Tous les bébés doivent être exclusivement nourris au sein de la naissance à l'âge de 6 mois. Les mères doivent recevoir des conseils et un soutien pour l'allaitement exclusif lors de chaque contact postnatal.	Recommandé
Protection, promotion et soutien de l'allaitement maternel dans les établissements fournissant des services de maternité et de néonatalogie¹⁷	43a. Les établissements fournissant des services de maternité et de néonatalogie doivent avoir une politique d'allaitement clairement écrite et systématiquement communiquée au personnel et aux parents.	Recommandé
	43b. Le personnel des établissements de santé qui fournit des services d'alimentation des nourrissons, notamment le soutien à l'allaitement, devrait avoir des connaissances, des compétences et des aptitudes suffisantes pour aider les femmes à allaiter.	Recommandé

C. SYSTÈMES DE SANTÉ ET INTERVENTIONS DE PROMOTION DE LA SANTÉ

Calendrier des contacts pour les soins postnataux	44. Un minimum de quatre contacts de soins postnataux est recommandé. Si la naissance a lieu dans un établissement de santé, les femmes et les nouveau-nés en bonne santé doivent recevoir des soins postnataux dans l'établissement au moins pendant les 24 heures qui suivent la naissance. Si l'accouchement a lieu à domicile, le premier contact postnatal doit avoir lieu le plus tôt possible dans les 24 heures suivant la naissance. Au moins trois contacts postnataux supplémentaires sont recommandés pour les femmes et les nouveau-nés en bonne santé, entre 48 et 72 heures, entre sept et 14 jours, et pendant les six semaines après la naissance.	Recommandé
Durée du séjour dans les établissements de santé après la naissance	45. Il est recommandé de fournir les soins aux femmes et aux nouveau-nés en bonne santé dans l'établissement de santé pendant au moins les 24 heures qui suivent un accouchement par voie basse.	Recommandé
Critères à évaluer avant la sortie de l'établissement après la naissance	46. Avant la sortie de l'hôpital des femmes et des nouveau-nés en bonne santé après la naissance, le personnel de santé doit évaluer les critères suivants afin d'améliorer les résultats pour la mère et le nouveau-né: - le bien-être physique de la femme et du bébé et le bien-être émotionnel de la femme; - les compétences et la confiance de la femme pour s'occuper d'elle-même et les compétences et la confiance des parents et des aidants pour s'occuper du nouveau-né; et - l'environnement domestique et d'autres facteurs susceptibles d'influencer la capacité à fournir des soins à la femme et au nouveau-né à la maison, et leur comportement de recherche de soins.	Recommandé

16 Intégré à partir du document *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn* de 2014.

17 Intégré à partir du document de l'OMS *Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services* de 2017.

Catégorie de soins	Recommandation	Catégorie de recommandation
Approches visant à renforcer la préparation à la sortie de l'hôpital après l'accouchement	47. La fourniture d'informations, les interventions éducatives et les conseils sont recommandés pour préparer les femmes, les parents et les aidants pour la sortie de l'hôpital après la naissance afin d'améliorer les résultats en matière de santé de la mère et du nouveau-né, et de faciliter le retour à la maison. Du matériel éducatif, tel que des brochures d'éducation écrites/numériques, des illustrations pour les populations semi-alphabètes et des aides au travail, doit être disponibles.	Recommandé
Visites à domicile pour les contacts postnataux	48. Les visites à domicile au cours de la première semaine après la naissance par un personnel de santé qualifié ou un travailleur de la santé communautaire formé sont recommandées pour les soins postnataux des femmes et des nouveau-nés en bonne santé. Lorsque les visites à domicile ne sont pas réalisables ou ne sont pas souhaitées, il est recommandé d'établir des contacts avec les services ambulatoires de soins postnataux.	Recommandé
La continuité des soins des sages-femmes¹⁸	49. Des modèles de continuité des soins sous la direction de sages-femmes, dans lesquels une sage-femme connue ou un petit groupe de sages-femmes connu soutient une femme sur l'ensemble du continuum constitué par les périodes prénatale, intrapartum et postnatale, sont recommandés pour les femmes dans les situations où les programmes de soins obstétricaux fonctionnent bien.	Recommandation spécifique au contexte
Composantes de la délivrance des soins prénatals se prêtant à la délégation des tâches¹⁹	50a. La délégation des tâches de promotion des comportements favorables à la santé maternel et néonatale ^g à une grande variété de catégories professionnelles, y compris des agents de santé sans formation médicale, des infirmiers/infirmières auxiliaires, des infirmiers/infirmières, des sages-femmes et des médecins, est recommandée.	Recommandé
	50b. La délégation des tâches pour fournir les méthodes de contraception ^h à une grande variété de catégories professionnelles, y compris des infirmiers/infirmières auxiliaires, des infirmiers/infirmières, des sages-femmes et des médecins, est recommandée.	Recommandé
Recrutement et maintien du personnel dans les zones rurales et éloignées²⁰	51. Les décideurs politiques devraient envisager un ensemble d'interventions couvrant l'éducation, la réglementation, les incitations et le soutien personnel et professionnel afin d'améliorer le développement, l'attraction, le recrutement et l'affectation du personnel de santé dans les zones rurales et reculées.	Recommandé
Participation des hommes aux soins postnataux et à la santé maternelle et néonatale²¹	52. Les interventions visant à promouvoir la participation des hommes pendant la grossesse, l'accouchement et après la naissance sont recommandées pour faciliter et soutenir l'amélioration des soins auto-administrés par les femmes, les pratiques de soins à domicile pour les femmes et les nouveau-nés, et le recours à des soins qualifiés pour les femmes et les nouveau-nés pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale, et pour accroître l'utilisation en temps opportun des soins en établissement pour les complications obstétricales et néonatales.	Recommandé avec un suivi et une évaluation ciblés

g Notamment la promotion des éléments suivants: les soins postnataux, la planification familiale (distribution de préservatifs [masculins et féminins] et d'autres moyens contraceptifs, initiation et distribution de contraceptifs oraux combinés, de contraceptifs oraux progestatifs et de contraception d'urgence, et informations et instructions générales sur la méthode des jours standard, la méthode des deux jours[®] et la méthode de l'aménorrhée lactationnelle), le dépistage tardif et le redépistage du VIH post-partum, le fait de dormir sous des moustiquaires imprégnées d'insecticide, les conseils nutritionnels, les compléments nutritionnels, les soins de base aux nouveau-nés, l'allaitement maternel exclusif et la vaccination conformément aux directives nationales.

h Notamment: mise en place et maintien de contraceptifs injectables à l'aide d'une seringue standard avec aiguille pour injection IM ou sous-cutanée, insertion de dispositifs intra-utérins (DIU), insertion d'implants contraceptifs.

18 Intégrée à partir des *Recommandations de l'OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive* de 2017.

19 Adapté et intégré à partir de la publication *Recommandations de l'OMS: optimisation des rôles du personnel de santé par la délégation des tâches pour améliorer l'accès aux interventions de santé maternelle et néonatale* de 2013.

20 Adapté et intégré à partir du document *Lignes directrices de l'OMS pour la production, l'attraction, le recrutement et la fidélisation des agents de santé dans les zones rurales et reculées* de 2021.

21 Retenu (suite à l'examen des nouvelles données) à partir du document *WHO recommendations on health promotion interventions for maternal and newborn health* 2015.

Catégorie de soins	Recommandation	Catégorie de recommandation
	Ces interventions sont recommandées, à condition qu'elles soient mises en œuvre de manière à respecter, promouvoir et faciliter les choix des femmes et leur autonomie dans la prise de décision, et à aider les femmes à prendre soin d'elles-mêmes et de leurs nouveau-nés.	
Fiches de santé à domicile ²²	53. L'utilisation des fiches de santé tenues à domicile en complément des fiches tenues par les établissements, est recommandée pour les soins de des femmes enceintes et en post-partum, des nouveau-nés et des enfants en vue d'améliorer les demandes de soins, la participation et le soutien des hommes dans les ménages, les pratiques de soins maternels et infantiles à domicile, l'alimentation des nourrissons et des enfants, et la communication entre les agents de santé et les femmes, les parents et les aidants.	Recommandé
Communication numérique ciblée avec les clients ²³	54. L'OMS recommande la communication numérique ciblée sur les clients pour modifier les comportements en matière de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale et infantile, à condition que les préoccupations relatives aux contenus sensibles et à la confidentialité des données soient prises en compte de manière adéquate.	Recommandation spécifique au contexte
Notifications numériques de naissance ²⁴	55. L'OMS recommande l'utilisation de notifications numériques de naissance dans ces conditions: • dans des contextes où les notifications fournissent des données au niveau individuel au système de santé et/ou à un système d'enregistrement des faits d'état civil et • où le système de santé et/ou le système d'enregistrement des faits d'état civil a la capacité de répondre aux notifications.	Recommandation spécifique au contexte

22 Adapté et intégré à partir du document *Recommandations de l'OMS sur les fiches de santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant tenues à domicile* de 2018.

23 Intégré à partir du document *WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening* de 2019.

24 Intégré à partir du document *WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening* de 2019.



**Organisation
mondiale de la Santé**

human
reproduction
programme **hrp.**
research for impact
UNDP · UNFPA · UNICEF · WHO · WORLD BANK

Recommandations de l'OMS concernant les soins maternels et néonataux pour une expérience positive de la période postnatale : résumé analytique [WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience: executive summary]

ISBN 978-92-4-004847-8 (version électronique)

ISBN 978-92-4-004848-5 (version imprimée)

© Organisation mondiale de la Santé 2022. Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence **CC BY-NC-SA 3.0 IGO**.

Traduction par Ocean Translations. L'OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. En cas d'incohérence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise est considérée comme la version authentique faisant foi.

Pour plus d'informations, contacter :

Organisation mondiale de la santé
Avenue Appia 20, CH-1211 Genève 27, Suisse

Département Santé sexuelle et reproductive, et recherche

Email: srhmp@who.int

Website: [www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-\(srh\)](http://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh))

Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, et vieillissement

Email: mnc@who.int

Website: www.who.int/teams/maternal-newborn-child-adolescent-health-and-ageing/

Département Santé mentale et usage de substances psychoactives

Email: mhgap-info@who.int

Website: www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use

Département Nutrition et sécurité alimentaire

Email: nutrition@who.int

Website: www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/overview

9789240048478

